

TECNOVIGILANCIA Y REACTIVOVIGILANCIA



Gestion tecnica y reglamentaria

2026

MARCO NORMATIVO



Decreto 4725 de 2005

Régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de dispositivos médicos.



Resolución 4816 de 2008

Establece el Programa Nacional de Tecnovigilancia y sus lineamientos operativos.



Guías INVIMA

Instructivos técnicos para el diligenciamiento del reporte FOREV y clasificación de eventos.



Decreto 4725 de 2005

Marco general de vigilancia sanitaria que incluye los reactivos de diagnóstico in vitro.



Resolución 2013 de 2019

Establece el Programa Nacional de Reactivovigilancia y sus procedimientos de reporte.



Decreto 3770 de 2004

Régimen de registro sanitario para reactivos de diagnóstico in vitro.



Guías técnicas INVIMA

Instructivos para el diligenciamiento del reporte FORE y clasificación de eventos con RDIV.

TIPOS DE VIGILANCIA



Vigilancia pasiva

Se basa en el reporte espontáneo y voluntario de eventos por parte de usuarios, prestadores o fabricantes, sin que la autoridad los busque activamente.

EJEMPLOS

- Un hospital reporta a INVIMA la falla de un desfibrilador tras detectarla en un paciente.
- Un laboratorio notifica un resultado erróneo de una prueba diagnóstica al usar un reactivo defectuoso.
- Un paciente informa a su EPS un daño causado por un implante.



Vigilancia activa

Es la búsqueda intencionada y sistemática de eventos mediante auditorías, seguimiento programado o revisión de historias clínicas, iniciada por la autoridad o el fabricante.

EJEMPLOS

- El fabricante hace seguimiento postcomercialización a una nueva válvula cardíaca en varias IPS.
- INVIMA audita periódicamente laboratorios que usan reactivos de alto riesgo.
- Una IPS revisa historias clínicas para buscar eventos no reportados con cierto dispositivo.

Tecnovigilancia vs Reactivovigilancia

Aspecto	Tecnovigilancia	Reactivovigilancia
Objeto	Dispositivos médicos	Reactivos de diagnóstico in vitro
Norma que crea el programa	Resolución 4816 de 2008	Resolución 2013 de 2019
Formato de reporte	FOREV	FORE
Riesgo principal	Daño físico directo al paciente	Diagnóstico erróneo o tardío

DEFINICIONES



Dispositivo médico

Instrumento, aparato, equipo o software usado en seres humanos con fines de diagnóstico, prevención, tratamiento o rehabilitación.



Reactivo de diagnóstico in vitro (RDIV)

Producto usado para examinar muestras biológicas fuera del cuerpo humano con fines diagnósticos.



Evento adverso

Daño no intencionado al paciente, operador o entorno, relacionado con el uso del producto en condiciones normales.



Evento adverso serio

Evento que causa muerte, amenaza la vida, incapacidad permanente o requiere hospitalización.



Incidente adverso

Situación que pudo haber causado daño, pero no llegó a producirlo ("casi evento").

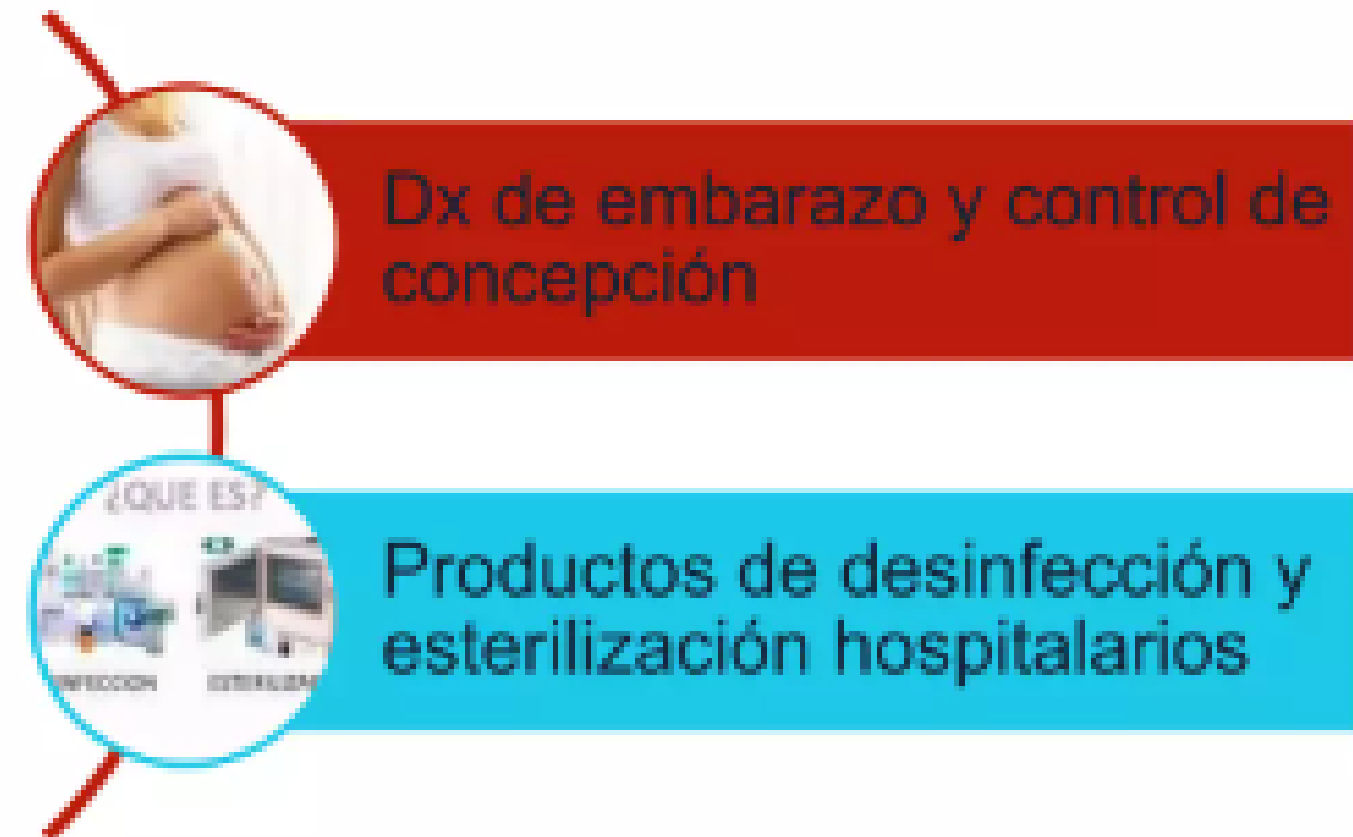
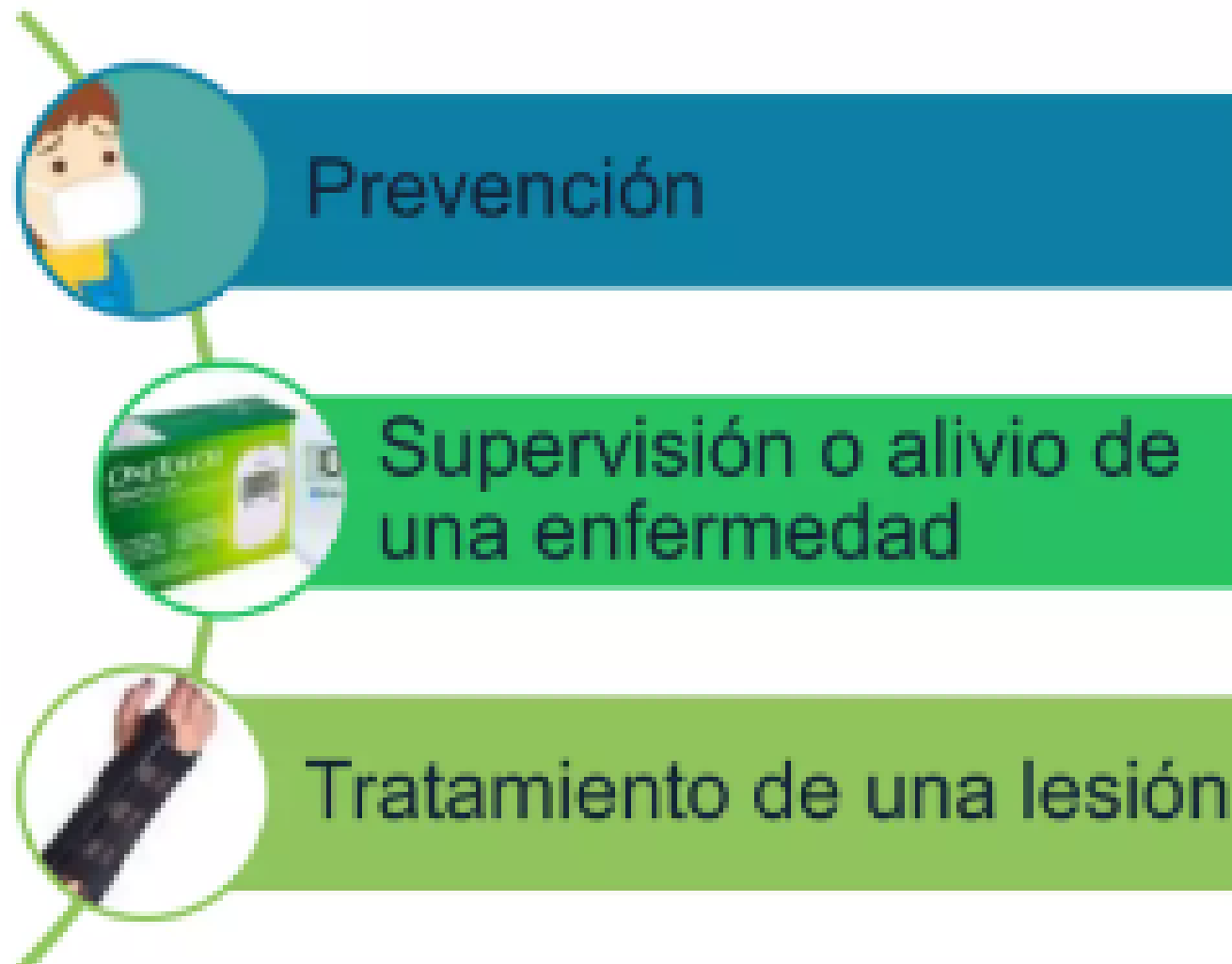


Alerta sanitaria / acción de campo

Comunicación o medida emitida por el fabricante o INVIMA ante un riesgo detectado en un producto ya comercializado.

Dispositivos Medicos

Cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomedico u otro similar o relacionado, utilizado solo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticosque intervengan en su correcta aplicación destinado por el fabricante para el uso en seres humanos en los siguientes casos.



CLASIFICACION DE LOS DISPOSITIVOS SEGUN SU RIESGO

Clase I (Bajo Riesgo)	Clase IIA (Riesgo Moderado)	Clase IIB (Riesgo Alto)	Clase III (Riesgo Muy Alto)
 Gasas, esparadrapos, cánulas nasales para oxígeno, bolsas de colostomía.	 Agujas hipodérmicas, catéteres periféricos intravenosos, equipos de venoclisis, guantes de examen.	 Condomes, apósitos no adherentes, bolsas de sangre (sin anticoagulantes).	 Catéteres venosos centrales (ej. Certofix), suturas de catgut cromado, cera para huesos.

TECNOVIGILANCIA

Conjunto de actividades que buscan identificar, evaluar y gestionar los eventos e incidentes adversos que se presentan durante el uso de dispositivos médicos.



Objeto de vigilancia

Dispositivos médicos en uso: equipos, insumos, implantes y software médico.



Qué se reporta

Eventos adversos, incidentes adversos y fallas de calidad detectadas en campo.



Quiénes participan

Fabricantes, importadores, prestadores de salud, usuarios e INVIMA.



Para qué sirve

Prevenir la recurrencia de eventos y proteger la seguridad del paciente.

REACTIVO VIGILANCIA

Vigilancia postmercado de los reactivos de diagnóstico in vitro (RDIV) usados en laboratorio clínico.



Objeto de vigilancia

Reactivos de diagnóstico in vitro: pruebas de laboratorio, kits diagnósticos, controles y calibradores.



Qué se reporta

Resultados erróneos, fallas de desempeño analítico y defectos que afectan el diagnóstico del paciente.



Quiénes participan

Laboratorios clínicos, fabricantes, importadores, IPS e INVIMA.



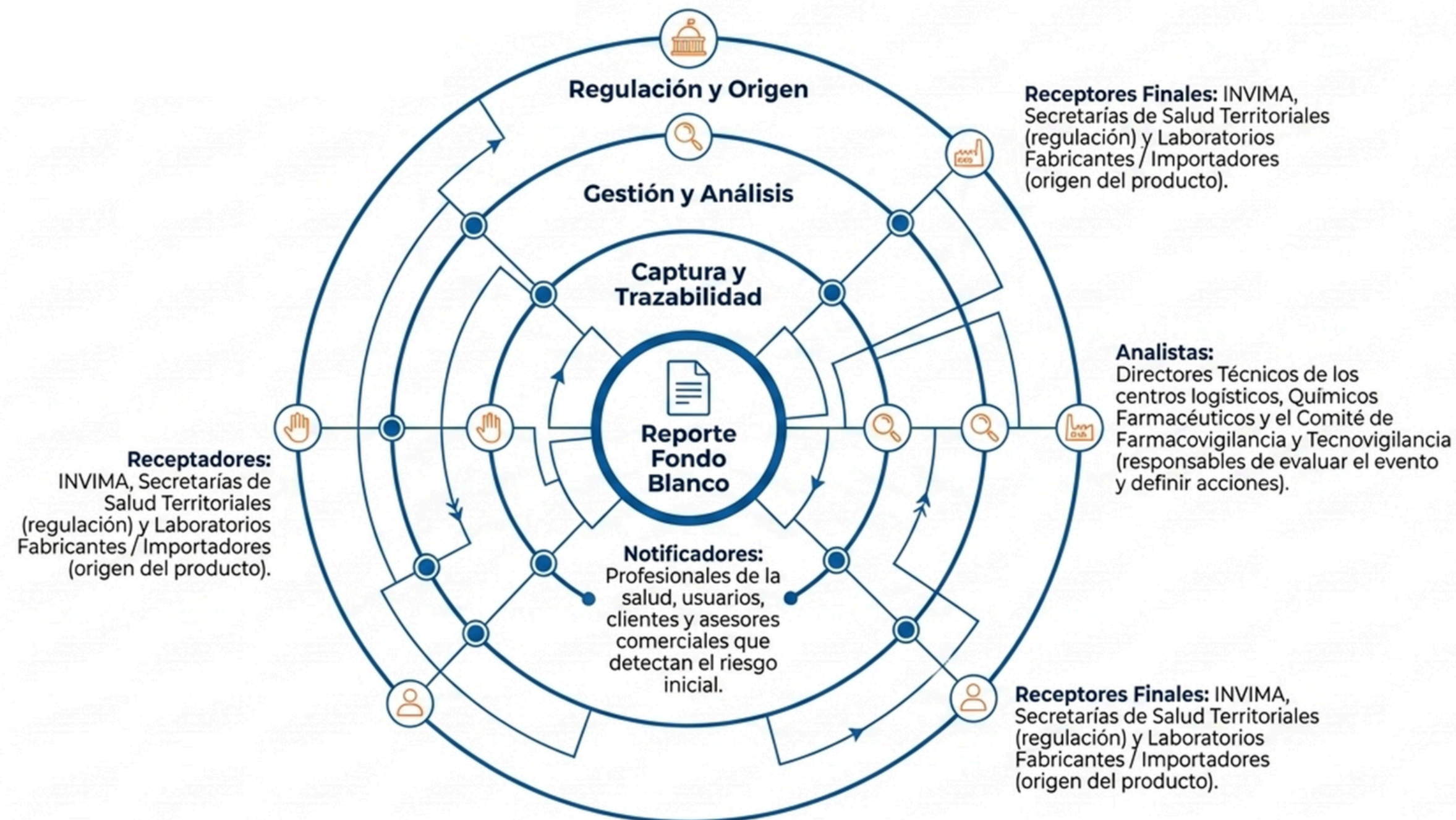
Para qué sirve

Garantizar la fiabilidad de los resultados diagnósticos y la seguridad del paciente.

CLASIFICACION DEL EVENTO SEGUN GRAVEDAD

Clasificación	Presencia de Daño	Estado del Dispositivo	Acción Requerida
● Indicio de Incidente	Falla detectada antes del uso. Ningún daño al paciente.	Retirado antes de interactuar con el paciente.	Reporte interno periódico.
● Incidente Adverso No Serio	Daño leve o falla que no causó daño por intervención médica oportuna.	Falla durante el uso; el dispositivo debe ser aislado.	Reporte a la autoridad (usualmente 30 días).
● Evento Adverso Serio	Muerte, deterioro grave de la salud o intervención quirúrgica necesaria para prevenirlo.	Dispositivo involucrado en daño crítico; cuarentena inmediata obligatoria.	Reporte inmediato / alerta temprana (72 horas).

ACTORES DENTRO DEL SISTEMA DE REPORTE



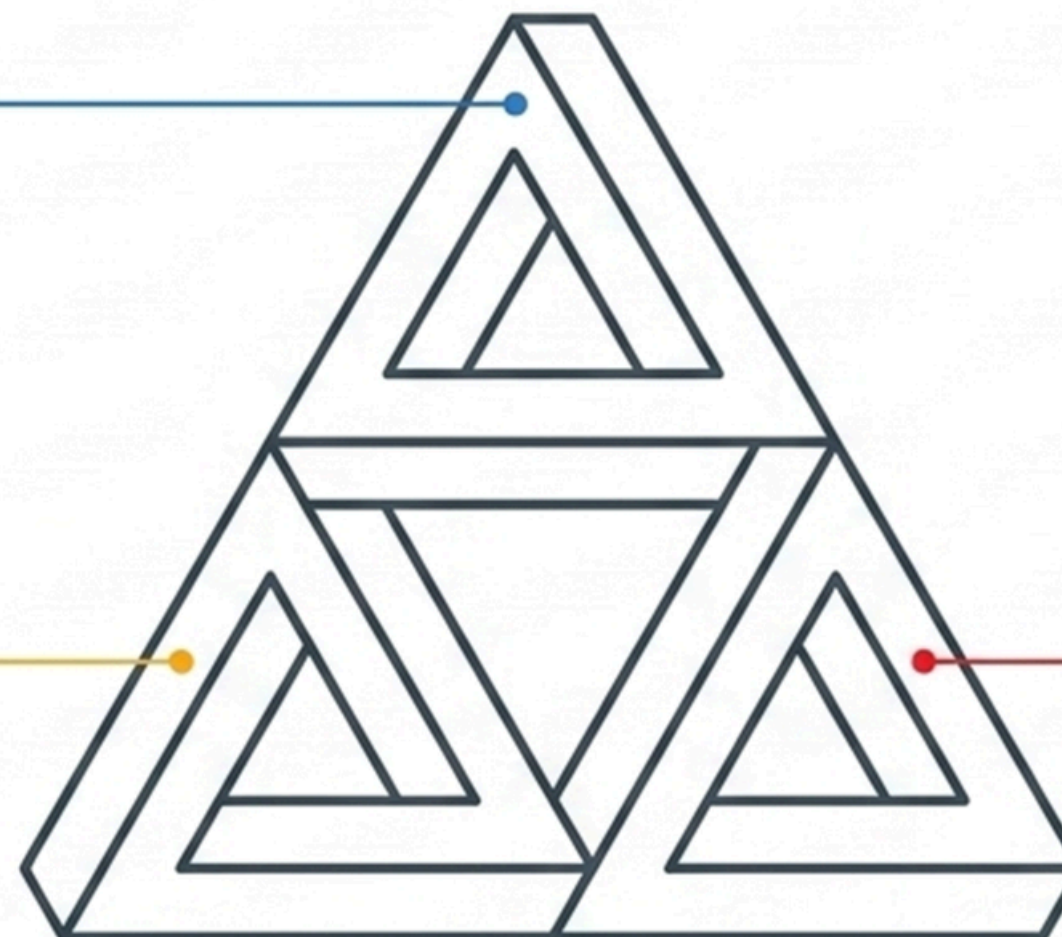
PRINCIPALES ITEM QUE DEBE TENER UN REPORTE

Identificación del Dispositivo

Marca, modelo, lote y número de serie.
Sin esto, el fabricante no puede investigar su línea de producción.

Contexto Clínico

¿Cómo se estaba usando? ¿Quién lo operaba? ¿Qué terapias concomitantes existían? Sin esto, no se puede descartar el error de uso.



Datos del Paciente

Edad, diagnóstico subyacente y descripción clínica del daño. Sin esto, es imposible medir la severidad del evento.

La ausencia de cualquiera de estos tres vértices transforma un reporte accionable en un dato muerto.

¿QUE SE DEBE DE REPORTAR?

Todo incidente o riesgo de incidente debe de reportarse independientemente de su desenlace, adicionalmente solo los eventos adversos que le hayan causado un daño al paciente o una lesión en su salud deben realizarse analisis de causa raiz y plan de acción.



1. Muerte o Riesgo Potencial

Incidentes que comprometen la vida del paciente u operador.



2. Lesiones en la Salud

Daños físicos, ya sean de carácter temporal o permanente.



3. Defectos de Calidad

Fallas de funcionamiento o características físicas/químicas contrarias a las autorizadas en el registro sanitario.



4. Errores de Uso

Problemas derivados de una aplicación o manejo incorrecto del dispositivo.

¿QUE DEBE CONTENER UN REPORTE?

1

Datos del reportante

Nombre, institución, cargo y datos de contacto de quien notifica el evento.

2

Datos del paciente

Iniciales, edad y sexo, sin información que permita identificarlo plenamente.

3

Datos del dispositivo o reactivo

Nombre comercial, marca, modelo, lote o serie, registro sanitario y fabricante.

4

Descripción del evento

Fecha, lugar y narración detallada de lo ocurrido.

5

Clasificación del evento

Tipo de evento (adverso, incidente o falla técnica) y su nivel de seriedad.

6

Desenlace del paciente

Recuperación total, secuela, hospitalización o muerte, si aplica.

7

Acciones inmediatas tomadas

8

Datos de diligenciamiento

FLUJO DEL REPORTE DE EVENTOS E INCIDENTES ADVERSOS



CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Clasificación	Presencia de Daño	Estado del Dispositivo	Acción Requerida
● Indicio de Incidente	Falla detectada antes del uso. Ningún daño al paciente.	Retirado antes de interactuar con el paciente.	Reporte interno periódico.
● Incidente Adverso No Serio	Daño leve o falla que no causó daño por intervención médica oportuna.	Falla durante el uso; el dispositivo debe ser aislado.	Reporte a la autoridad (usualmente 30 días).
● Evento Adverso Serio	Muerte, deterioro grave de la salud o intervención quirúrgica necesaria para prevenirlo.	Dispositivo involucrado en daño crítico; cuarentena inmediata obligatoria.	Reporte inmediato / alerta temprana (72 horas).

Como reportar los eventos e incidentes con dispositivos médicos





REPORTE DIGITAL

FARMACOVIGILANCIA • TECNOVIGILANCIA • ERRORES DE DISPENSACIÓN

A partir de la fecha, todos los reportes se realizan de forma rápida, segura y centralizada desde la página web oficial de DISCOLMETS.



TODOS LOS REPORTE AHORA SON DIGITALES

Centralizamos nuestros procesos para brindar una gestión más ágil, segura y eficiente.

¿QUÉ PUEDES REPORTAR?



FARMACOVIGILANCIA

Reporte de eventos adversos relacionados con medicamentos.



TECNOVIGILANCIA

Reporte de incidentes relacionados con dispositivos médicos.



ERRORES DE DISPENSACIÓN

Reporte de novedades durante el proceso de dispensación.

¿CÓMO REALIZAR TU REPORTE?

- Ingresa a www.discolmets.com.co
- Haz clic en **Farmacovigilancia**
- Selecciona el tipo de reporte y presiona **Ir al Formulario**
- Completa el formulario y envía tu reporte



Dirígete al menú inferior y selecciona la opción **Farmacovigilancia**.

Serás redirigido a la sección de Farmacovigilancia.



Elige el módulo que corresponda a tu reporte y haz clic en **Ir al Formulario**.



Diligencia toda la información solicitada y envía tu reporte. **¡Tu reporte es muy importante!**



ACCEDER DIRECTAMENTE

ESCANEANDO EL CODIGO QR O INGRESANDO AL LINK DIRECTO

www.discolmets.com.co/vigilancia.php



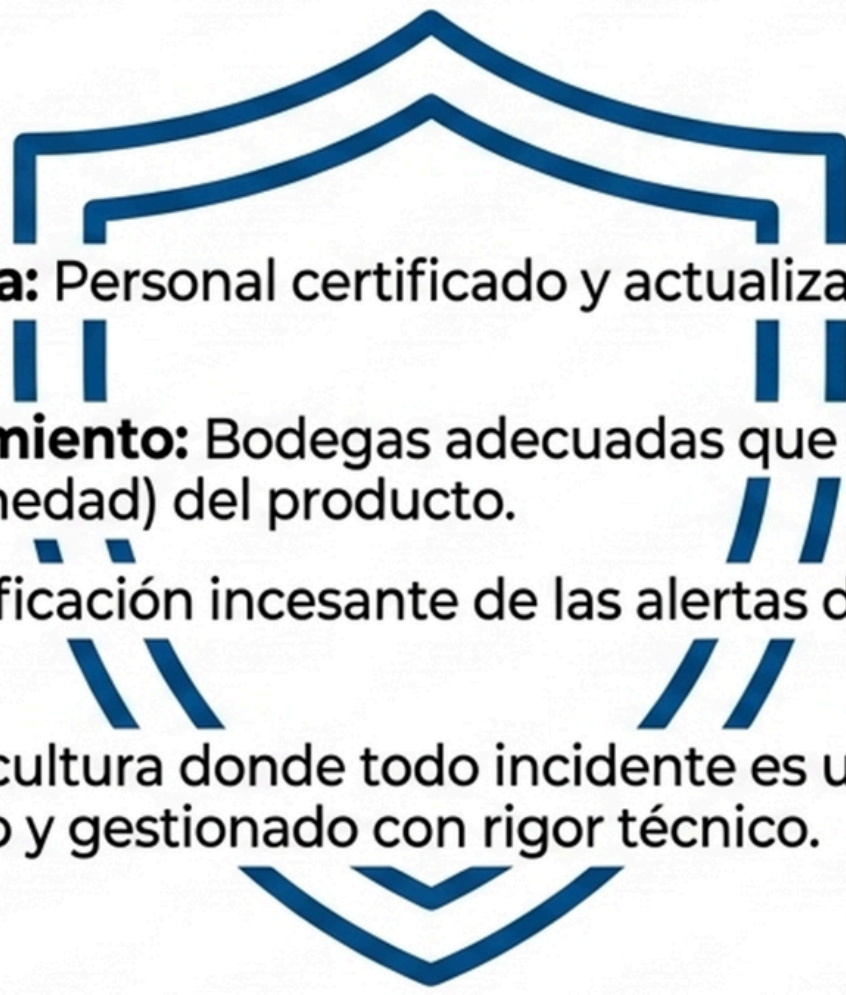
Tu reporte fortalece la **seguridad del paciente**, mejora nuestros procesos y contribuye a una atención de mayor calidad.

GESTION DE LOS RIESGOS Y VIGILANCIA



GESTION DE LOS RIESGOS Y VIGILANCIA

El éxito de la vigilancia sanitaria en DISCOLMETS S.A.S. BIC no depende solo del formulario, sino **de la cultura** logística y clínica que lo respalda.

- 
- ✓ **Capacitación Continua:** Personal certificado y actualizado en la manipulación de dispositivos.
 - ✓ **Rigor en el Almacenamiento:** Bodegas adecuadas que aseguran la integridad física y ambiental (temp/humedad) del producto.
 - ✓ **Vigilancia Activa:** Verificación incesante de las alertas del INVIMA y trazabilidad impecable.
 - ✓ **Cero Omisiones:** Una cultura donde todo incidente es un punto de datos vital, reportado de inmediato y gestionado con rigor técnico.



¡Muchas gracias!

Dudas e inquietudes